Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de São Borja

Rua Aparício Mariense, 1773 - Bairro: Centro - CEP: 97670000 - Fone: (55) 3431-2737 - Email: frsaoborja3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001477-86.2021.8.21.0030/RS

AUTOR: CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA LOPES

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

VISTOS, ETC.

CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA LOPES ajuizou ação ordinária em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, ambos qualificados na inicial.

Relatou que é portadora da patologia CID 34.9 (carcinoma de pequenas células de pulmão com acometimento avançado (doença extensa), devendo ser submetida a tratamento quimioterápico em razão da agressividade da patologia. Afirmou que necessita receber o medicamento Atezolizumabe (Tecentriq), para controle da doença, evitar progressão, aumentar sobrevida e aumentar a qualidade de vida. Referiu que ao solicitar a medicação junto a requerida, teve seu pedido não autorizado, sob o argumento de que o mesmo não está previsto nas suas atuais recomendações técnicas em oncologia. Postulou, em sede de tutela de urgência, seja determinado que o requerido forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Atezolizumabe (Tecentriq) 1200 mg, de uso continuado (1 ampola a cada 21 mês). Requereu a procedência dos pedidos para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a requerida a custear os medicamentos postulados até que perdure a sua necessidade. Pediu a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Acostou documentos - Evento 01.

Deferido o benefício da gratuidade judiciária e indeferido o pedido liminar - Evento 03.

A parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para determinar que o agravado forneça à agravante o fármaco TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE), na dosagem de 1200mg a cada 21 dias, por tempo indeterminado, no prazo máximo de 10 dias úteis, sob pena de bloqueio de valores - Evento 09.

Sobreveio manifestação da parte requerida informando o cumprimento da determinação de fornecimento do medicamento TEZOLIZUMABE (TECENTRIQ) - Evento 14.

Citado, o requerido apresentou contestação - Evento 18. Informou que o IPE-Saúde possui um protocolo oncológico elaborado pela Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul, o qual prevê as medidas a serem adotadas em cada neoplasia, nos diferentes estágios e tratamentos da doença. Referiu que as Recomendações Técnicas em Oncologia - RTO adotadas pelo Instituto são periodicamente revistas considerando as recomendações dos melhores estudos da medicina baseada em evidência. Afirmou que o medicamento postulado não está previsto nas recomendações do Protocolo Oncológico do Instituto requerido. Referiu que para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora, dependendo do estágio da doença, a autarquia disponibiliza os fármacos Etoposide, Cisplatina, Vincristina, Etoposídeo, Carboplatina e Irinotecano, em relação aos quais não se demonstrou nenhuma ineficácia ou inferioridade em relação ao(s) químico(s) ora postulado(s). Alegou que há contraindicação ao uso do medicamento. Asseverou que há de se considerar que o IPE-Saúde, como entidade à qual compete a prestação de serviços de saúde aos funcionários públicos estaduais, não pode admitir nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada, mormente por não haver no caso em testilha qualquer indicativo da ineficácia dos medicamentos oferecidos pela autarquia. Postulou a improcedência dos pedidos e, em caso de procedência, que seja observada a denominação comum brasileira do fármaco pleiteado. Juntou documentos - Evento 14 e 18.

A autora manifestou-se sobre a contestação e reiterou os termos da inicial - Evento 21.

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas (Evento 25), a requerida pugnou pela intimação da parte autora acerca da possibilidade de substituição dos fármacos pleiteados pelos disponibilizados no SUS, através de laudo médico fundamentado - Evento 29.

Determinada a intimação da parte demandada para que comprove, no prazo de 72 (setenta e duas horas) o fornecimento do fármaco TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE), na dosagem de 1200mg, sob pena de bloqueio de valores - Evento 32.

A parte demandada apresentou manifestação e acostou documentos - Evento 37.

A autora apresentou manifestação informando que não há possibilidade de substituição do fármaco e acostou laudo médico - Evento 43.

O Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos - Evento 49.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.

O processo transcorreu regularmente, não havendo nulidades a serem decretadas, comportando julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

O art. 196 da Constituição Federal de 1988 dispõe que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e dos outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*, considerando-se "Estado" em seu sentido amplo.

A Lei de nº 8.080/90 que dispõe, em todo o território nacional, sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes ao SUS, disciplina em seu artigo 2° que *"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*.

E ainda, a Lei de nº 9.908/93 regra em seu art. 1° que é dever do Estado fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com a aquisição.

Desse modo, não há distinção entre os entes, cabendo a todos o fornecimento de medicação e do tratamento necessário. Eventual regramento infraconstitucional – Portarias, Leis Estaduais, etc. - dividindo as responsabilidades, em nada altera a responsabilização conjunta e solidária dos entes públicos.

Assim, poderá o cidadão optar por qualquer dos entes para o recebimento de assistência à saúde, já que a Lei Federal nº 8.080/90, atribui a todos os entes federados a prestação dos serviços de saúde à população. E, da interpretação e aplicação sistemática das disposições constitucionais acima referidas, resulta certo que o direito à vida e à saúde estão garantidos de forma objetiva pelo direito material, residindo com o Estado a obrigação de assegurá-lo.

E mais, a partição de competência interna dos entes da federação, que impera administrativamente entre estes, não afasta a responsabilidade perante a parte autora. As compensações financeiras entre os entes públicos que administram o sistema único de saúde dizem respeito tão somente a estes, não podendo afetar e impedir o direito constitucional à saúde dos cidadãos.

A saúde deve ser assegurada imediatamente, independentemente de trâmites administrativos e orçamentários entre os entes públicos responsáveis. A preservação da vida e da saúde do cidadão é absolutamente urgente e tem que ser prestada prontamente.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJRS a respeito do tema:

> *APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEDICAMENTO. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE. 1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §1º, do CPC/2015. 1. Responsabilidade solidária entre os entes federados pelo fornecimento de medicamentos e demais ações de saúde. Entendimento predominante junto ao Egrégio 2º Grupo Cível, a que pertence esta Colenda 4ª Câmara Cível.* ***2. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*** *3. Sentença de procedência na origem. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70078902319, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 24/04/2019)*

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, no seguinte sentido:

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

In casu, quanto ao fato de que seria inviável a concessão do medicamento à parte autora, por ausência de cobertura, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Isso porque, restou demonstrado no caso em testilha a necessidade de utilização do medicamento e que este não pode ser substituído por outros fármacos abrangidos pela cobertura do plano de saúde, pois as alternativas não surtem o mesmo efeito na parte requerente.

O art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 12.134/04, dispõe que integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde.

Sendo assim, o critério adotado é o da exclusão expressa, de modo que, em não havendo exclusão expressa de fornecimento do medicamento, este deve ser fornecido ao paciente.

A corroborar o exposto:

*RECURSO INOMINADO. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO. **A Lei Complementar Estadual n.º 12.134/04, em seu artigo 2º, que instituiu o IPE-SAÚDE, garante cobertura ampla sobre atendimentos médicos, hospitalares, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde. De modo que, da leitura conjunta com os termos da Resolução nº 21/79, que regulamenta a assistência médico-hospitalar prestada pelo IPERGS, fica claro o critério eleito para a definição dos serviços sob cobertura dessa Autarquia, qual seja, o da exclusão expressa. Não havendo exclusão expressa nas regras reguladoras do Plano IPE-Saúde, o fornecimento do fármaco necessário ao tratamento da parte autora, desde que abarcado por alguma das hipóteses genéricas do artigo 2º da LC nº 12.134/04, deverá ser objeto de cobertura.** De outra banda, no que tange ao termo a quo para a incidência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, decorrente de fornecimento de tratamento médico, os valores despendidos e, devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71008229965, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 27/03/2019) Grifei.*

Ademais, deve ser salientado que, mesmo que houvesse exclusão expressa, muito embora seja cediço que a Administração Pública e suas autarquias devem ser regidas pelo princípio da legalidade, sendo vedado agir em desacordo com a lei, haveria hipótese de concorrência de normas constitucionais cogentes, quais sejam, a legalidade, prevista no art. 37 da Carta Magna, e a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1°, inc. III, da Carta Política, como fundamento do Estado Democrático de Direito.

Deste modo, como a dignidade da pessoa humana deve se sobrepor à norma que regula questões meramente administrativas, sob pena de afronta aos direitos humanos e, por conseguinte, violação ao bem jurídico maior, qual seja, a vida, impõe-se a procedência do pedido, pois demonstrada a eficácia do medicamento para moléstia da parte autora, bem como comprovado que a parte demandante não possui condições de arcar com o custeio do fármaco, fato corroborado por ser atendida pela Defensoria Pública e, ainda, diante da impossibilidade de substituição por alternativas da rede pública, para fins de condenar o demandado ao fornecimento do remédio buscado.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência do STJ:

*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 1. **A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedente**s. 2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 20/09/2013) Grifei. Destaquei.*

*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- **A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- "É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar."** (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) Grifei. Destaquei.*

No mesmo sentido, o posicionamento do TJRS:

*REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PERTUZUMABE (PERJETA). CARCINOMA DE MAMA ESQUERDA (CID C50.3). IPÊ-SAÚDE. DEVER DO DEMANDADO DE FORNECIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. A NÃO INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NOS PROTOCOLOS DO PLANO NÃO É ÓBICE À SUA CONCESSÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. I. Remessa Necessária não conhecida. O custo anual da medicação não supera os valores constantes no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, impondo-se o seu não conhecimento. II. Fornecimento do fármaco. **Muito embora o medicamento pleiteado não se encontre previsto no Protocolo Oncológico da autarquia, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não-inclusão dos medicamentos em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos.** III. Procura à rede pública por não fazer parte da lista de dispensação. Não há falar em procura à rede Pública (CACONs e UNACONs) por não estar listado na Tabela de Assistência Médica do Instituto, visto que se trata de relação contratual, além disso, a rede pública é destinada justamente às pessoas que não possuem plano de saúde, não havendo qualquer obrigação para que a segurada busque a rede pública de saúde. IV. Ordem de Serviço 01/93- medicamento domiciliar. Em nenhum momento foi solicitado uso de medicamento domiciliar e, conforme laudo médico acostado aos autos, o médico que acompanha a paciente afirmou que a aplicação deve ser em ambiente especializado, que não compreende, por óbvio, a residência da autora. V. Administração e organização da Autarquia pelo Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário cumpre a aplicação e interpretação do sistema jurídico sempre que instado, não podendo ser excluída da sua apreciação lesão ou ameaça a direito, sob pena de afrontar direito fundamental garantido na CF/88 (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). VI. Verba honorária. Não se apresenta excessiva a verba honorária arbitrada em 5% sobre o valor da causa (R$ 81.850,00), de modo que a sentença merece ser mantida no ponto. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70079398863, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 08/11/2018) Grifei. Destaquei.*

*APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. IPÊ-SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO COM ABIRATERONA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. FÁRMACO INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O DEMANDANTE. FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS DE ACORDO COM A DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA. I) **A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde, conforme arts. 1º e 2º da Lei Complementar 12.134/04.** II) A indicação do tratamento postulado pelo demandante foi prescrito por médico de sua confiança. É ele quem tem reais condições de indicar o melhor tratamento para seu paciente e de prescrever a medicação mais adequada. III) A indicação dos medicamentos por meio de seu nome comercial constitui-se em mera irregularidade, mostrando-se possível ao ente público o fornecimento segundo a Denominação Comum Brasileira, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.787/99 Lei do Medicamento Genérico, desde que respeitada a dosagem prescrita pelo médico e as substâncias que compõem o seu princípio ativo, e, em caso de indisponibilidade no mercado do medicamento genérico, deve ser fornecido o fármaco pela marca comercial. IV) Embora seja o arbitramento de multa, na maioria das vezes, meio eficaz para compelir ao cumprimento de decisão, na atual situação financeira*

do Estado do Rio Grande do Sul e de suas autarquias, sua imposição carece de efeito prático imediato e acaba onerando ainda mais os cofres públicos. V) Honorários advocatícios. Adequação do valor arbitrado. Manutenção. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70077098119, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 10/05/2018) Grifei. Destaquei.

Sendo assim, como o objeto da ação diz respeito ao asseguramento do cumprimento do direito constitucional à saúde, bem como da dignidade da pessoa humana, havendo indicação de utilização do fármaco e sendo ele útil para o tratamento da moléstia da parte, a procedência dos pedidos constitui medida impositiva.

Do bloqueio de valores

Para o caso de descumprimento, regular a determinação de bloqueio de tais valores, tendo em vista que visa à efetividade da medida ou a obtenção do resultado prático perseguido, nos termos do que dispõe o art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, mais eficaz que a fixação de multa.

Nesse sentido:

*APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ÁCIDO URSODEXICÓLICO, RESIDRONATO SÓDICO, VITAMINA D E CÁLCIO - PARA TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS CATALOGADAS SOB CID 10 K 74.3 E CID M 81.0. RECURSO DO ESTADO INTEMPESTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACOS PELOS CONSTANTES NA LISTA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA DEMANDANTE. COMPROVADA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. CABIMENTO. HONORÁRIOS MINORADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul não conhecido, considerando a ausência do requisito extrínseco relativo à tempestividade. 2. Incumbe aos Municípios, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico necessário para tratar as enfermidades dos cidadãos. Portanto, é reconhecida a legitimidade passiva do Município de Caxias do Sul. 3. Descabe ao Poder Judiciário determinar a substituição do fármaco recomendado pelo médico responsável para tratamento da parte autora por outro, constante em lista do SUS. É o profissional da Medicina, que mantém contato direto com a paciente, quem tem plenas condições de determinar o tratamento médico adequado. 4. Devidamente comprovada a hipossuficiência da demandante para arcar com os custos do tratamento postulado sem o prejuízo de sua subsistência, conforme documentos acostados aos autos. 5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido pelo art. 196 da CF. Por tal razão, questões de ordem principiológica e/ou orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não socorre o apelante, pois a teoria da reserva do possível, que é atrelada ao fator custo, não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde. 6. **Determinação de bloqueio ou sequestro de valores que encontra fundamento no art. 536, § 1º, do CPC, constituindo providência necessária para garantir a efetividade da medida. Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp nº 1069810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC.** 7. Honorários que, embora não possam espelhar valor irrisório, devem ser fixados de forma comedida e atentar ao trabalho desenvolvido no curso da lide, em atenção aos vetores do artigo 85, §§ 2º e 8º, do novo Código de Processo Civil, vigente à época. Hipótese em que é cabível a minoração pretendida. 8. Pretensão de prequestionamento que não deve ser acolhida, pois desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada. APELAÇÃO DO ESTADO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃ CIVIL, C/C ARTIGO 169, XXXIX DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. (Apelação Cível Nº 70071259444, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/10/2016) Grifei*

No caso concreto, é de ser determinado o fornecimento do medicamento pleiteado, enquanto perdurar a necessidade da parte autora, ou o bloqueio dos valores correspondentes, caso não efetuado o cumprimento da obrigação, porque a credibilidade da prescrição médica que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para desautorizar até mesmo a pretensão de substituição dos fármacos por alternativas do SUS.

Da denominação comum brasileira

Existindo no laudo médico o nome do princípio ativo dos medicamentos, nada obsta aos demandados a adoção do medicamento genérico, utilizando a Denominação Comum Brasileira, conforme dispõe a Lei nº 9.787/99, desde que não exista contraindicação pelo assistente médico da parte autora.

Assim, nada resta a ser aditado e a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

ISSO POSTO, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA LOPES** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, o que faço na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar e **CONDENAR** o requerido ao fornecimento do medicamento Atezolizumabe (Tecentriq) 1200 mg, pelo prazo necessário ao tratamento, devendo a parte autora comprovar a necessidade a cada 06 (seis) meses.

Diante da sucumbência, condeno os requeridos, solidariamente, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais vão fixados em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), o que faço em conformidade com o que preceitua o artigo 85, §§ 2º e 8°, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

Em caso de interposição de recurso (art. 1.012, CPC):

1. Verifique a escrivania se o recurso versa unicamente sobre a fixação de honorários sucumbenciais em favor do(s) apelante(s), sendo o caso, o pagamento das custas ocorrerá no final do processo (art. 13, §2°, Lei 14.634/2014);

2. Intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1.010, §1º, CPC);

3. Apresentadas as contrarrazões, verifique a escrivania a ocorrência da hipótese de suscitação de preliminar nas contrarrazões, referentes a decisão anterior do Juízo que não comportou agravo de instrumento (art. 1.009, §2º, CPC);

4. Na hipótese supra, intime(m)-se o(s) apelante(s) para manifestação acerca das preliminares, em 15 dias (art. 1.009, §2º, CPC);

5. Tudo cumprido, ou em caso de não apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 1.010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com baixa.

Sentença publicada e registrada no sistema. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO BERTOLAZI GAUER, Juiz de Direito**, em 13/1/2022, às 14:32:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10013819967v9** e o código CRC **843f1a70**.